

TEMA 1.16 • PEDIATRÍA

Infecciones Respiratorias en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Infecciones Respiratorias en Pediatría

1. Resfrío Común

Causa: Virus respiratorios (más frecuente: **Rhinovirus**). También adenovirus, VRS, metapneumovirus.

- **Clínica:**
- Rinorrea, tos, disfonía/odinofagia, obstrucción nasal
- Fiebre habitualmente < 39°C (o sin fiebre)
- **Examen pulmonar NORMAL** (infección respiratoria alta, no baja)
- **Tratamiento (sintomático):**
- **Suero fisiológico intranasal** → primera medida (descongestión)
- Paracetamol si fiebre o dolor
- No indicar antitusivos (aumentan riesgo de neumonía)

2. Influenza

Causa: Virus Influenza A, B, etc.

- **Clínica:** Tríada = **Fiebre alta** (≥ 39°C) + **Tos** + **Mialgias** + compromiso del estado general.
- Examen pulmonar **normal** (infección respiratoria alta)

Diagnóstico: Clínico. Confirmar con PCR o inmunofluorescencia si hay duda o epidemiología relevante.

Tratamiento en niños: Solo **paracetamol** (sintomático).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El **oseltamivir (Tamiflu)** **NO** está indicado en niños, ni de alto ni bajo riesgo. Solo en adultos con comorbilidades de alto riesgo.

3. Neumonía en Pediatría

Causas según Edad

TABLA 1.16.1: EDAD VS AGENTE MÁS FRECUENTE

EDAD	AGENTE MÁS FRECUENTE
Recién nacido	<i>Streptococcus agalactiae</i> (grupo B)
< 1 año (no RN)	Virus respiratorio sincicial (VRS)
> 1 año	Neumococo (<i>S. pneumoniae</i>)
Escolar	Neumococo + Mycoplasma (similar frecuencia)

Diagnóstico

Clínico (fundamental): tos + expectoración + fiebre + **examen pulmonar alterado** (crepitaciones, matidez, broncofonía, respiración soplate).

La radiografía de tórax complementa pero **no reemplaza el diagnóstico clínico**.

Tratamiento

TABLA 1.16.2: SITUACIÓN VS ANTIBIÓTICO

SITUACIÓN	ANTIBIÓTICO
Ambulatorio (bien)	Amoxicilina VO
Hospitalizado	Penicilina EV
RN/neonato	Ampicilina + Cefotaxima (o Ampi + Gentamicina)

NOTA CLÍNICA

En niños basta Penicilina/Amoxicilina (a diferencia del adulto donde se prefiere ceftriaxona para cubrir *H. influenzae* resistente).

4. Neumonía Atípica

- **Causa principal:** ***Mycoplasma pneumoniae*** (sin pared celular → betalactámicos no sirven).
- También: *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella pneumophila*
- En RN (~20 días): *Chlamydia trachomatis* (contagio en canal del parto, precedida de conjuntivitis neonatal)
- **Clínica:**
- Cuadro **arrastrado** (1–3 semanas): inicia como resfrío → lentamente empeora
- Examen pulmonar: sibilancias + crepitaciones; compromiso **bilateral**
- Radiografía: patrón intersticial bilateral, infiltrado alveolar-intersticial
- **Tratamiento: Azitromicina** × 5 días.
- Alternativa: levofloxacino o moxifloxacino (evitar quinolonas en niños cuando sea posible)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La clave de la neumonía atípica: cuadro bilateral lento que comenzó como un resfrío + no responde a betalactámicos → *Mycoplasma* → azitromicina.

5. Coqueluche (Tos Convulsiva / Tosferina)

- **Causa:** ***Bordetella pertussis*** (principal). *B. parapertussis* (similar pero más leve).
- Síndrome coqueluchoide (clínica similar): también por *Mycoplasma*, VRS, parainfluenza, adenovirus.

Fases Clínicas

TABLA 1.16.3: FASE VS DURACIÓN

FASE	DURACIÓN	CLÍNICA
Catarral	1–2 semanas	Resfrío inespecífico (moco, tos leve, odinofagia) — contagiosa
Paroxística	2–4 semanas	Tos en quintas + gallito inspiratorio + petequias faciales + vómitos (tos emetizante) + apneas
Convalecencia	Semanas	Tos residual decreciente

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Apneas en lactantes < 6 meses son la manifestación más grave → riesgo de muerte. Un lactante de 3 meses con tos paroxística + apneas = sospechar coqueluche.

- **Diagnóstico:**
- **PCR en secreciones nasofaríngeas** (elección actual)
- Inmunofluorescencia directa (antes era el gold standard)
- Examen físico y radiografía: inespecíficos (no diagnósticos)
- **Tratamiento: Azitromicina** × 5 días.
- Útil solo en fase catarral o primeros días de fase paroxística → reduce contagiosidad
- NO indicar antitusivos (aumentan riesgo de neumonía)

Manejo de Contactos

Contactos que reciben azitromicina profiláctica:

- **Siempre:** Contacto **sintomático** (cualquier fase)
- **Recomendado (alto riesgo):**
- - Lactantes < 1 año (riesgo de muerte)
- - < 2 años con < 3 dosis de vacuna
- - Adultos > 65 años u hospitalizados
- - Embarazadas en 3er trimestre

- - Personas con enfermedad respiratoria, cardíaca o epilepsia

Vacunación: Completar esquema incompleto en contactos. Vacunar a **embarazadas** (en el 3er trimestre) para traspasar anticuerpos al RN antes de su primera dosis a los 2 meses.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Escolar de 12 años con tos persistente de 10 días, fiebre 38°C, malestar general. Rx tórax: infiltrado intersticial bilateral difuso. Hemograma con leucocitos normales. ¿Cuál es el tratamiento de elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Infecciones Respiratorias en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Resfrió e influenza: pulmón NORMAL en radiografía; tratamiento sintomático; oseltamivir solo en grupos de riesgo <48h
- Neumonía bacteriana >1 año: Streptococcus pneumoniae, condensación lobar; amoxicilina oral 80 mg/kg/día
- Neumonía atípica (adolescentes): Mycoplasma pneumoniae; infiltrado bilateral; azitromicina 3-5 días
- Coqueluche: tos quintosa + gallito inspiratorio + petequias faciales; PCR nasofaríngea; azitromicina + notificación
- Crup (laringitis aguda): parainfluenza, estridor inspiratorio, tos perruna; dexametasona IM + adrenalina nebulizada
- Bronquiolitis: VRS <2 años, sibilancias + taquipnea; soporte con O2, SNG; sin broncodilatadores de rutina

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFECCIONES RESPIRATORIAS EN PEDIATRÍA)

PREGUNTA 1

Escolar de 12 años con tos persistente de 10 días, fiebre 38°C, malestar general. Rx tórax: infiltrado intersticial bilateral difuso. Hemograma con leucocitos normales. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A) Amoxicilina oral 80 mg/kg/día por 7 días
- B) Azitromicina 10 mg/kg/día por 3-5 días
- C) Oseltamivir 75 mg c/12h por 5 días
- D) Cefuroxima EV hospitalaria
- E) Observación sin antibióticos, es viral

PREGUNTA 2

Lactante de 5 meses con cuadro de 2 días de tos, coriza, y ahora taquipnea (FR 60), sibilancias espiratorias y retracción subcostal. T° 37.8°C. Es invierno. ¿Cuál es el manejo correcto?

- A) Salbutamol nebulizado 2 puff cada 20 minutos por 1 hora
- B) Corticoides sistémicos para reducir la inflamación
- C) Soporte con oxígeno suplementario si SpO2 <90-92% + hidratación por SNG si no tolera oral
- D) Amoxicilina oral por sobreinfección bacteriana probable
- E) Alta con corticoide inhalado preventivo

PREGUNTA 3

Lactante de 3 meses con tos paroxística nocturna de 2 semanas con emisión de vómito al final y un episodio de apnea. Antecedente de contacto con hermano mayor con "resfrió prolongado". PCR nasofaríngea positiva para Bordetella pertussis. ¿Cuál es la conducta?

- A) Amoxicilina oral ambulatoria por 7 días
- B) Azitromicina oral ambulatoria + notificación obligatoria
- C) Hospitalizar + azitromicina + monitorización cardiorrespiratoria + notificación obligatoria
- D) Oseltamivir + hospitalización por influenza severa
- E) Alta con salbutamol inhalado para los episodios de tos

RESUMEN: INFECCIONES RESPIRATORIAS EN PEDIATRÍA

:::warning El oseltamivir (Tamiflu) NO está indicado en niños, ni de alto ni bajo riesgo. Solo en adultos con comorbilidades de alto riesgo. :::
 Clínico (fundamental): tos + expectoración + fiebre + examen pulmonar alterado (crepitaciones, matidez, broncofonía, respiración soplaante).
 :::note En niños basta Penicilina/Amoxicilina (a diferencia del adulto donde se prefiere ceftriaxona para cubrir H. influenzae resistente). :::